Uso extendido, marco ausente

Inteligencia artificial generativa en la práctica clínica de médicos de la provincia de Buenos Aires. Estudio transversal.

Dra. DURAN TANIA ELIZABETH.



157 MÉDICOS · OCTUBRE DE 2026

MATERIALES Y MÉTODOS · PROVINCIA DE BUENOS AIRES

157 médicos, encuestados en octubre de 2026

DISEÑO

Observacional, descriptivo y analítico, de corte transversal

INSTRUMENTO

Encuesta anónima en línea: 36 preguntas, 32 ítems analizados

DIFUSIÓN

Grupos de residencias y servicios; muestreo en cadena, no probabilístico

ANÁLISIS

IC95 % de Wilson; chi² o Fisher; OR, Mann-Whitney y regresión logística

MUESTRA

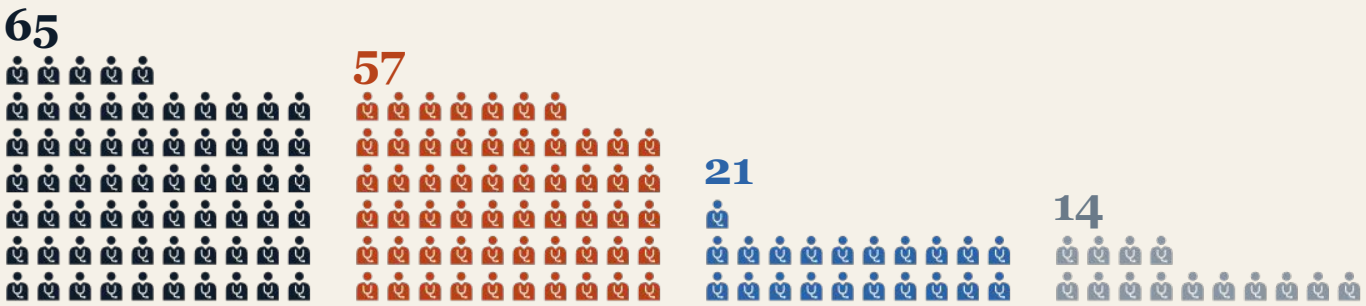
73,2 % mujeres

68,2 % pediatría

96,8 % hospital público

59,9 % conurbano sur

Quiénes respondieron



Planta
médicos de planta

Residentes
R1 a R4+:
12 · 24 · 14 · 7

Guardia
sin cargo de planta

Otras
concurrentes y otras

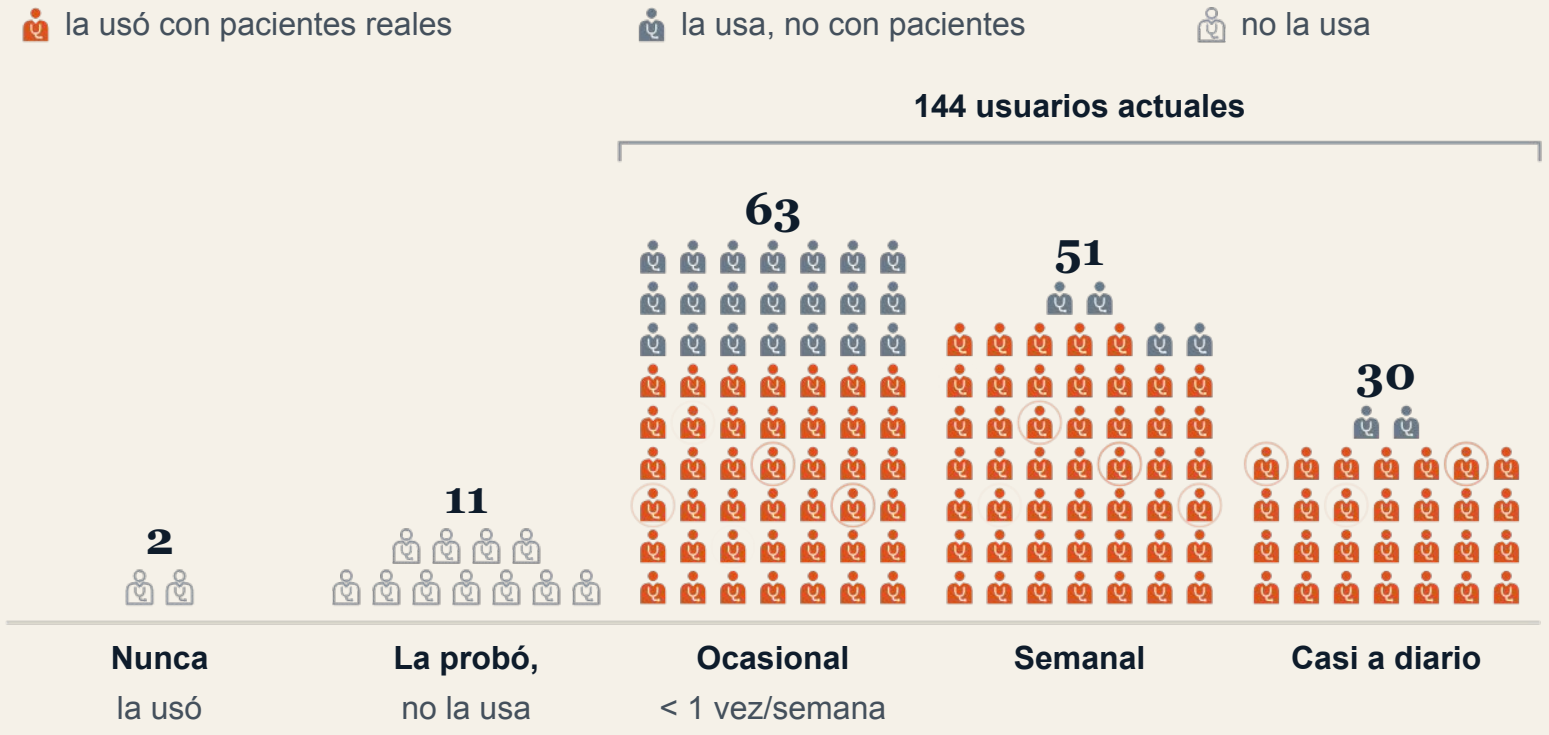
Denominadores · cada análisis usa su propia base



Análisis exploratorio, sin ajuste por multiplicidad; p < 0,05 a dos colas; sin imputación

ADOPCIÓN · MUESTRA TOTAL, N = 157

La IA no está llegando a los hospitales: ya está adentro



91,7 %
usa IA generativa

IC95 % 86,3–95,1

51,6 % al menos semanalmente

74,5 %
la usó con **pacientes reales**

117 de 157 · sobre todo dosis, interacciones y dudas de guardia

Nunca la habían usado

2023	**65,4 %**
2026	**1,3 %**

2023: dermatólogos, con ChatGPT

VISIBILIDAD · USAN LA IA EN EL TRABAJO, N = 118

Está en el trabajo diario, pero más de la mitad no se ve



44,1 %

52 la usan abiertamente

es algo normal entre colegas y jefes

línea de visibilidad institucional

55,9 %

sin visibilidad institucional

- **59** solo con colegas de confianza
- **7** prefieren no comentarlo

Donde el servicio **lo fomenta**



7 de 8

la usan abiertamente

Donde el servicio **lo desaconseja**



7 de 10

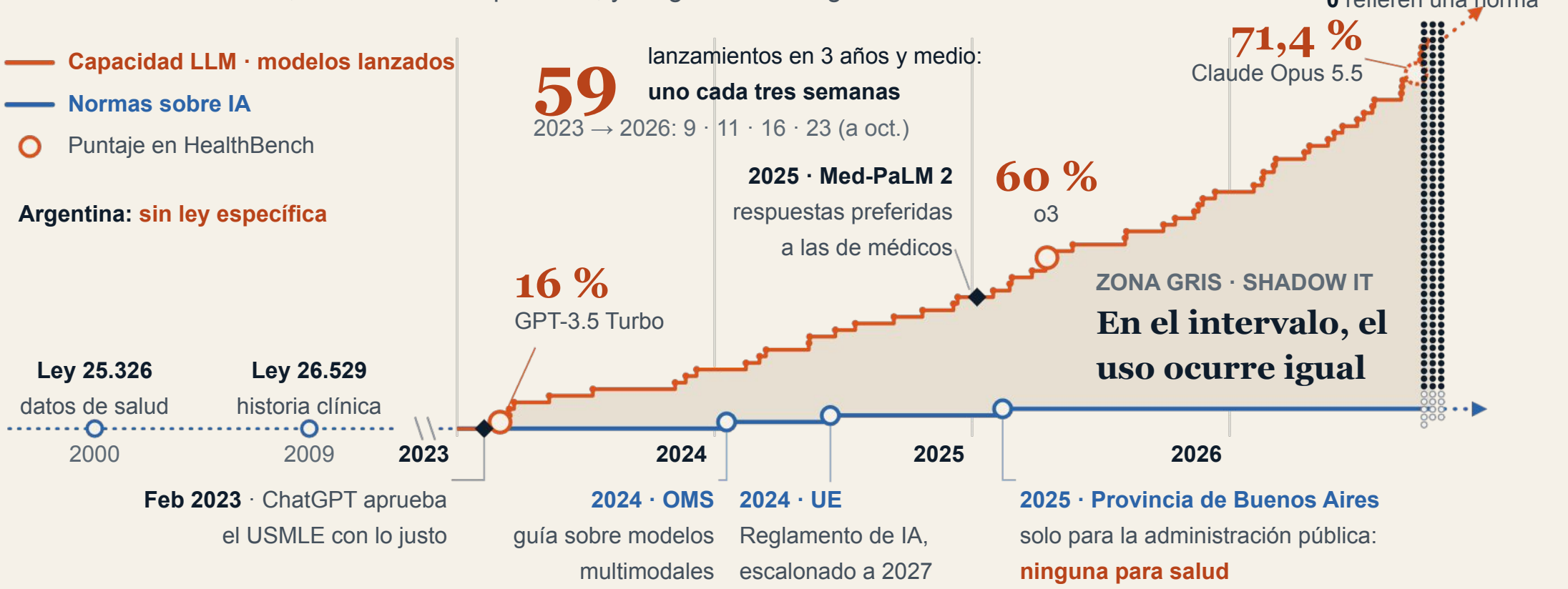
la ocultan… y la usan igual

En el resto: 40,9 % la usa abiertamente

LA BRECHA · DOS VELOCIDADES

Capacidad en meses, normas en años

El médico resuelve solo, con una cuenta personal, y carga con el riesgo.



Lanzamientos: modelos de uso general de OpenAI, Google y Anthropic, mar. 2023–oct. 2026 · HealthBench: Arora RK et al. 2025;

PROVISIÓN

El acceso es enteramente personal

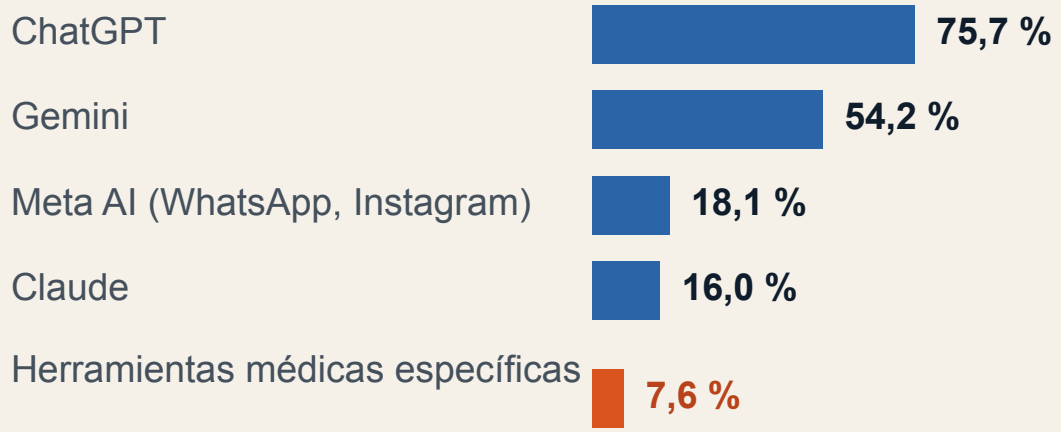
0

cuentas institucionales referidas por los 144 usuarios

77,8 %
usa solo versiones gratuitas

16,0 %
tiene acceso institucional a UpToDate, Dynamed u otro recurso pago

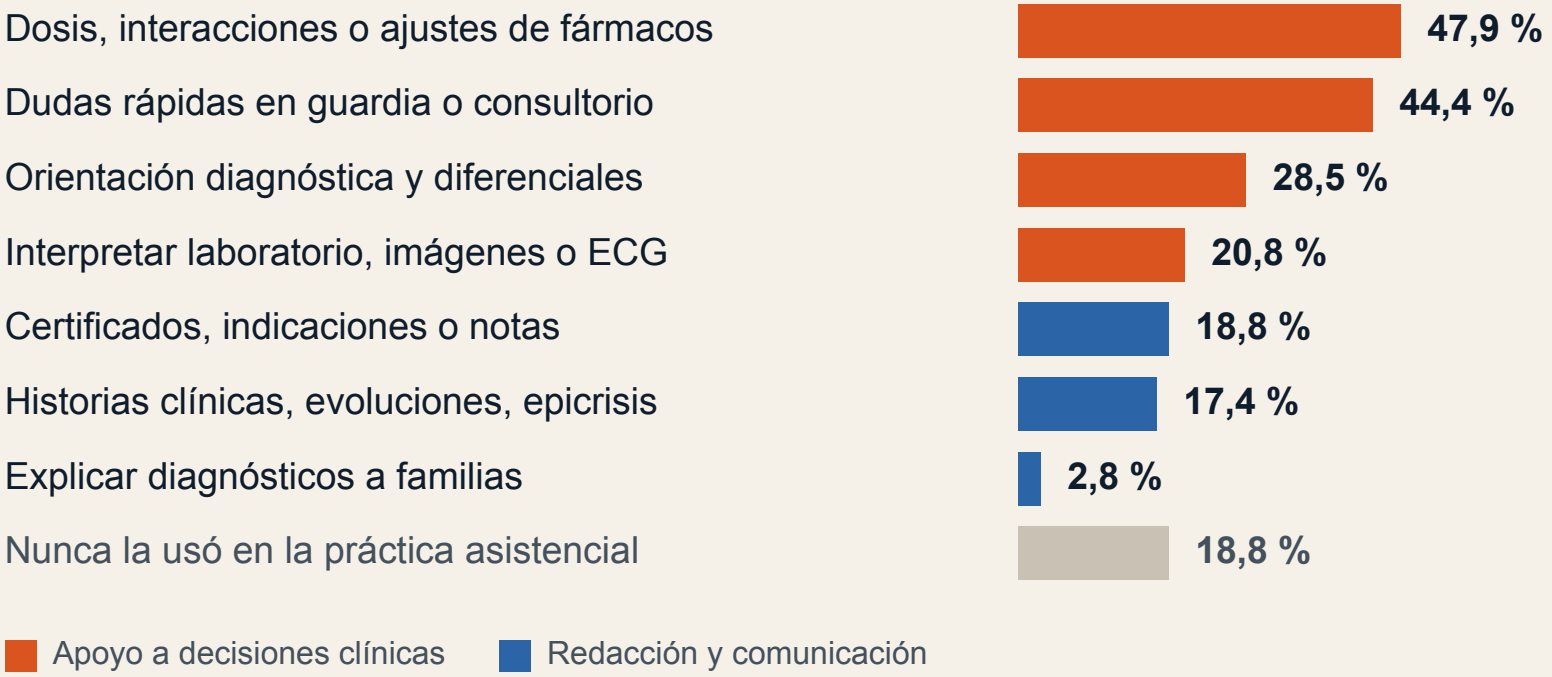
Herramientas que usan (respuesta múltiple)



Usuarios n = 144 · 19,4 % paga una suscripción propia; 2,8 % usa una cuenta compartida pagada por otro

USO ASISTENCIAL

8 de cada 10 usuarios la emplearon en tareas con pacientes reales

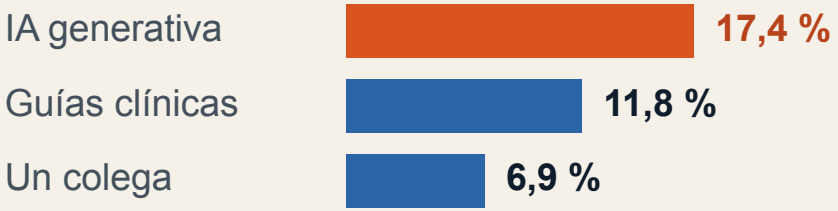


Usuarios n = 144; respuesta múltiple · 81,2 % de los usuarios = 74,5 % del total (IC95 % 67,2–80,7)

PRIMER RECURSO ANTE UNA DUDA CLÍNICA

Uno de cada seis recurre primero a la IA, antes que a una guía o a un colega

¿A qué recurre primero?



Recurre primero a la IA, según acceso a un recurso institucional de apoyo clínico

0 de 23
con acceso institucional (UpToDate, Dynamed u otro)

20,7 %
sin acceso institucional (p = 0,014)

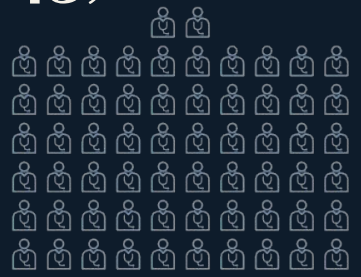
En la urgencia, el médico usa lo que tiene a mano, y eso es lo que la institución decidió, u omitió, proveer.

Usuarios n = 144 · 23 usuarios con acceso institucional a un recurso pago de apoyo clínico

PRIVACIDAD · USUARIOS DE IA GENERATIVA, N = 144

Más de la mitad ingresó datos o imágenes de pacientes reales

43,1 % (62)



Sin ingreso
de datos ni imágenes[1]

43,8 % (63)



Sin identificar
datos o imágenes tapadas[2]

13,2 % (19)

Identificables
nombre, DNI, HC o imagen



34,7 %
sabía que los textos pueden almacenarse fuera del país y usarse para entrenar modelos

10,4 %
revisó o cambió alguna vez la configuración de privacidad de la herramienta

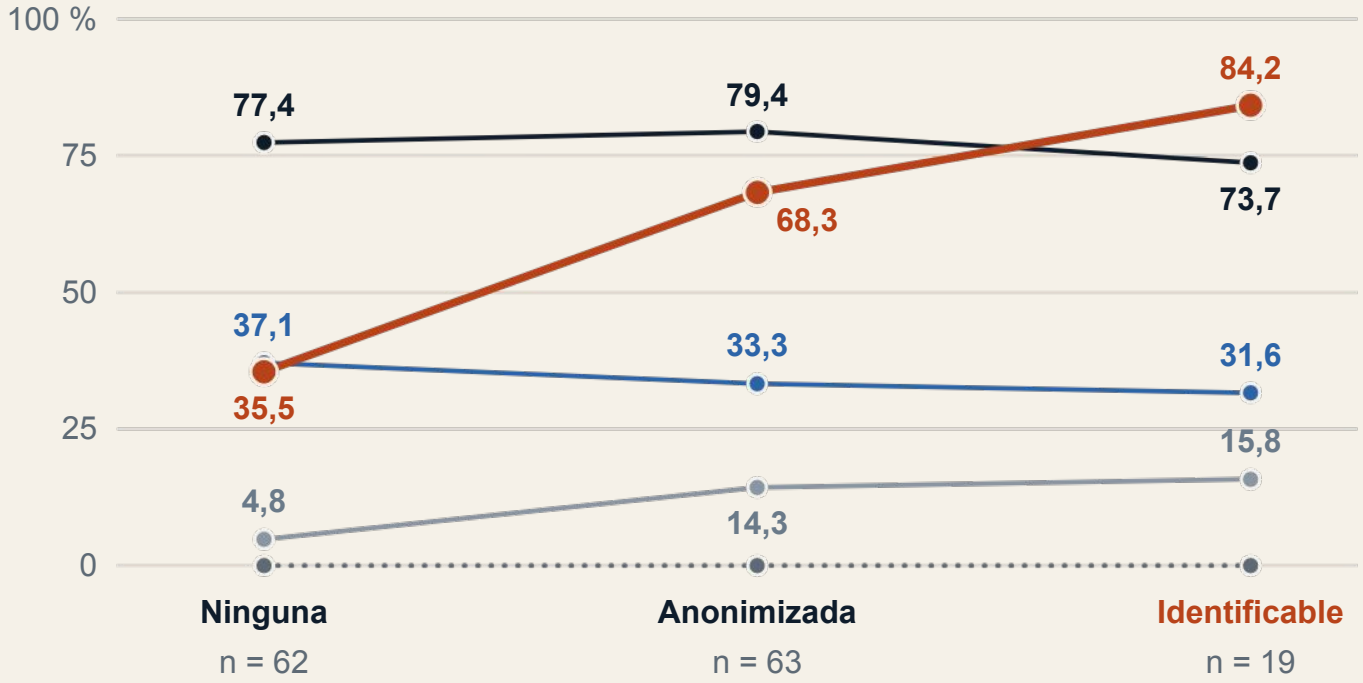
85,4 %
de quienes ingresaron datos (70 de 82) nunca revisó la configuración

Ingresó datos o imágenes: 56,9 % (IC95 % 48,8–64,7); identificables: 13,2 % (IC95 % 8,6–19,7) · [1] Incluye 2 que prefirieron no responder · [2] Según lo declarado; no se verificó la anonimización

EL CRUCE CENTRAL · SEGÚN EL NIVEL MÁXIMO DE DATOS INGRESADOS, N = 144

Más exposición, más uso; lo demás no cambia

No parece un problema de valores, sino de condiciones.



La usa al menos una vez por semana
p < 0,001

sube

Postura restrictiva ante el escenario
descriptivo

Sabía adónde van los datos
p = 0,865

Revisó la privacidad
p = 0,136

Conoce una norma institucional
0 en los tres niveles

no cambia

Porcentajes dentro de cada nivel de exposición · Ningún encuestado refirió una norma institucional

ACTITUD Y CONDUCTA

Las actitudes restrictivas conviven con conductas opuestas

Escenario: Un colega sube a ChatGPT la foto de una historia clínica con nombre y DNI



Inaceptable | Aceptable solo con los datos tapados | Aceptable

51,0 %
de quienes lo juzgaron **inaceptable** había ingresado datos de pacientes

73,7 %
de los 19 que expusieron datos **identificables** sostenía una postura restrictiva

No parece un problema de valores, sino de condiciones.

Muestra total n = 157 · Los residentes fueron menos categóricos: 26,3 % vs 44,0 % lo juzgó inaceptable (OR 0,45; IC95 % 0,22–0,92; p = 0,028)

GOBERNANZA INSTITUCIONAL · MUESTRA TOTAL, N = 157

0 de 157

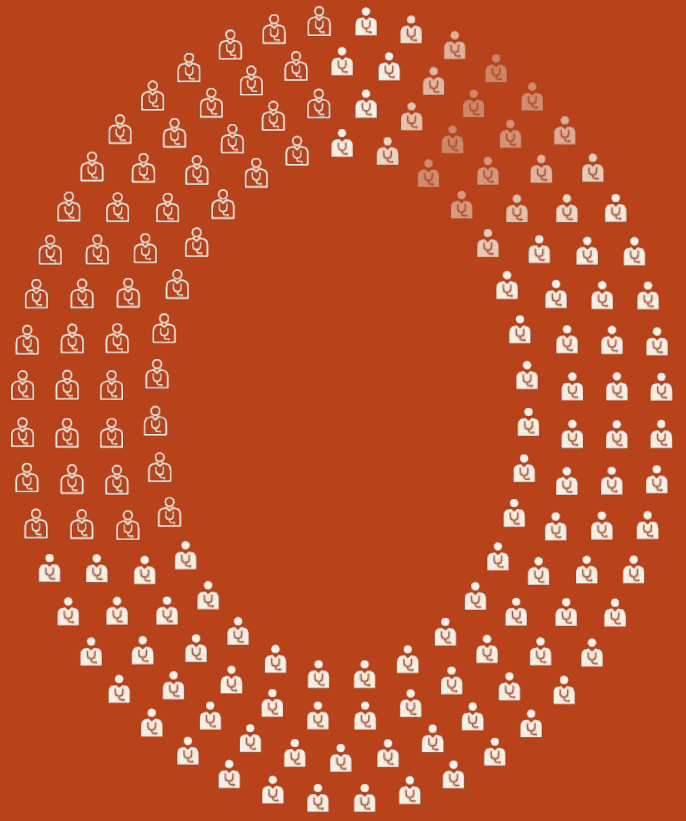
médicos encuestados refirió conocer una norma institucional sobre IA generativa

68,2 %
afirma que no existe

31,8 %
no sabe si existe

52,9 %
dice que en su servicio el tema nunca surgió

Una norma que los profesionales desconocen difícilmente pueda orientar su práctica cotidiana.



107 dicen que no existe 50 no saben

«No existe»: IC95 % 60,5–74,9 · La provincia dictó en 2025 directrices de uso de IA generativa para su administración pública, sin una norma específica para el ámbito sanitario

RESIDENTES FRENTE AL RESTO DE LOS MÉDICOS

Quien más usa, más confía y más se expone es quien está en formación

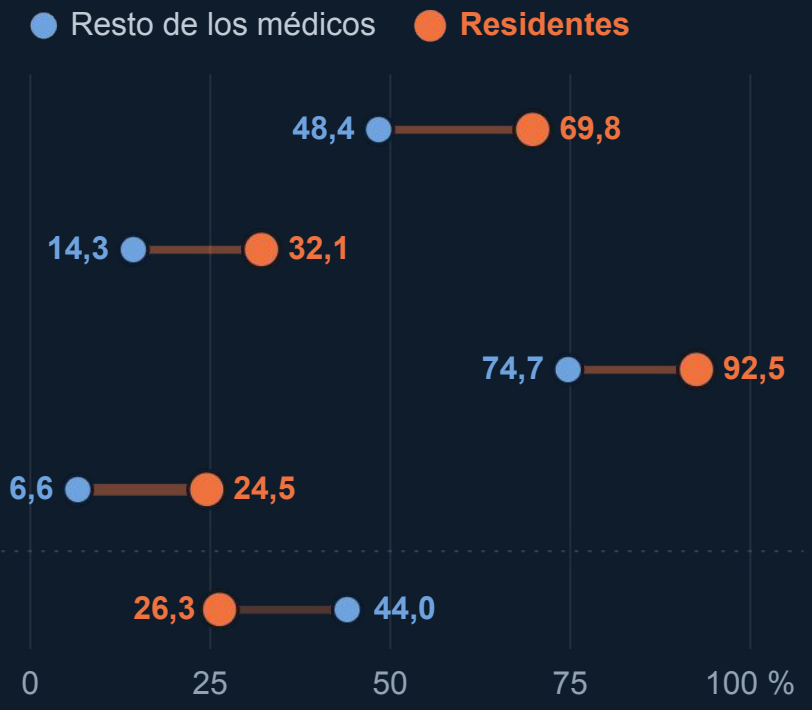
La usa al menos una vez por semana
53 vs 91 · OR 2,5 · p = 0,012

La usa casi todos los días
53 vs 91 · OR 2,8

La usó con pacientes reales
53 vs 91 · OR 4,1

Expuso datos identificables
13 de 53 vs 6 de 91 · OR 4,60 *

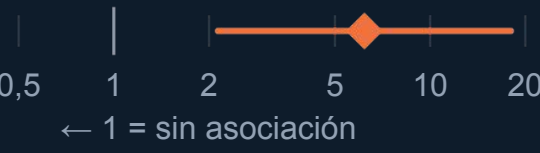
Juzga inaceptable subir la HC
57 vs 100 · OR 0,45 · p = 0,028



Exponer datos identificables
OR ajustado e IC95 %

Ser residente
3,50 (1,17–10,46)
p = 0,025

Uso casi diario
6,19 (2,13–18,00)
p < 0,001

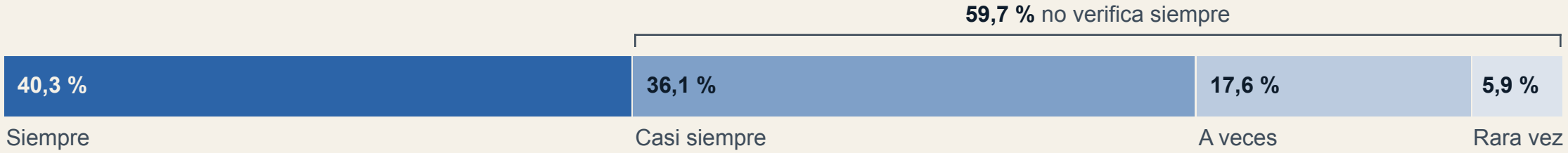


Resto: planta, guardia y otras situaciones · Usuarios: 53 residentes vs 91; HC: muestra total · * OR sin ajustar · Confianza media (1–5): 3,26 vs 3,01 (p = 0,030) · Modelo ajustado con 19 eventos exploratorio

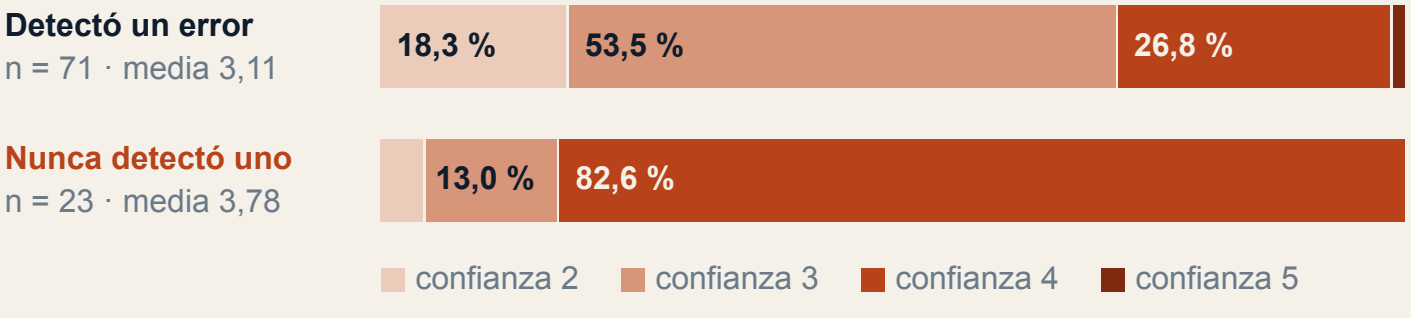
FORMACIÓN · VERIFICACIÓN Y ERRORES

Seis de cada diez no verifican siempre; quien nunca detectó un error confía más

Antes de usarla con un paciente, ¿verifica la respuesta en otra fuente? n = 119



Confianza (1 = nada, 5 = mucha) según si alguna vez detectó un error



confía 4 o 5

28,2 %

82,6 %

Detectó alguna vez información incorrecta o inventada

Uso casi diario

24 de 24

Resto de los usuarios

67,1 %

Sin correlación entre confianza y verificación (rho 0,02; p = 0,820) · Confianza: Mann-Whitney p < 0,001 · Diarios frente al resto: Fisher p < 0,001 · Uno refirió que el error influyó en una decisión, sin consecuencias

PROPUESTA · SON LAS 3 DE LA MAÑANA Y SURGE UNA DUDA CLÍNICA

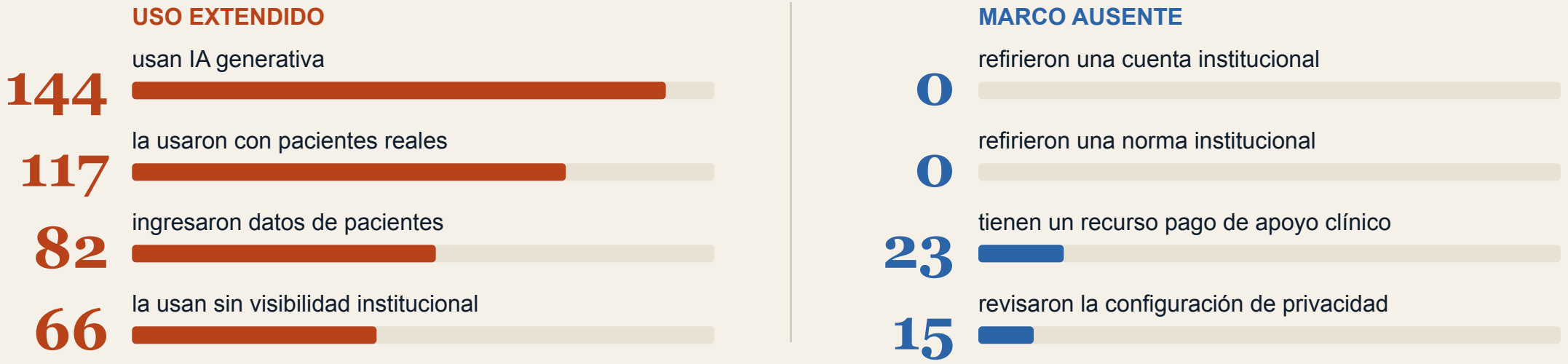
La misma guardia, con un marco institucional

	1 Surge una duda	2 Abre la herramienta	3 Escribe el caso	4 Lee la respuesta	5 Decide y lo cuenta
Hoy según la encuesta	**17,4 %** recurre primero a una IA; con UpToDate o similar: 0 de 23	**0** cuentas institucionales; 77,8 % usa versiones gratuitas	**56,9 %** ingresó datos de pacientes; 13,2 %, identificables	**59,7 %** no verifica siempre en otra fuente	**55,9 %** la usa sin visibilidad; ninguno de 157 refirió una norma
Con marco qué pilar interviene	**Provisión** Recursos de apoyo clínico basados en evidencia, a mano	**Provisión** Herramienta institucional con acuerdo de datos y sin entrenamiento	**Protección** Norma de usos permitidos y anonimizar antes de consultar	**Formación** Verificación sistemática; módulo obligatorio para residentes	**Protección** **Formación** Reportar incidentes sin sanción; uso visible y auditable

CONCLUSIÓN

Uso extendido, marco ausente

De los 157 médicos encuestados…



Faltan condiciones, no solo información.

La exposición crece con el uso, no con un menor conocimiento sobre privacidad.

Sin marco, el uso se vuelve invisible.

El riesgo queda en cada profesional, en especial en los residentes.

Donde hay recursos, la IA no es la primera opción.

El apoyo clínico institucional se asoció con no recurrir primero a la IA (0 de 23).

PARA CERRAR

Uso extendido, marco ~~ausente~~ *por construir*

La IA ya está cambiando la práctica clínica.

La responsabilidad de cuidar a nuestros pacientes sigue siendo nuestra.